12.1.7. 진단명 및 진단코드 관리

제 정 일	2018.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의무기록위원회, 의무기록팀				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 12.1 의료정보/의무기록 관리 JCI Standard 7th Edition: MOI.4, 8.1

제1조 (목적)

1. 진료정보의 핵심인 진단의 선정방법과 기재방법을 명시하여 환자의 정확한 진단명 및 진단코드를 선정, 관리함으로써 진료, 연구, 행정 등 다양한 목적에 정확하고 효율적으로 이용될 수 있게 함이다.

제2조 (정의)

1. 최종진단(Final diagnosis): 진료에 관련된 모든 평가와 검사가 완료된 후 최종적으로 내려진 진단이다.
2. 주진단(Principal diagnosis): 진료기간 중 최종적으로 진단받은 질환으로서, 치료나 검사에 대한 환자의 요구가 가장 컸던 질환이다. 이러한 질환이 둘 이상 있을 때는 의료자원을 가장 많이 사용하게 했던 질환이다.
3. 기타진단(Additional diagnosis): 진료기간 중 주진단과 함께 있었거나 발생된 병태로서 환자진료에 영향을 주었던 질환이다. 이번 진료기간 중 다루지 않은 과거에 진료받았던 질환은 포함되지 않는다.
4. POA(Present on Admission): 환자의 입원 당시에 가지고 있던 각종 동반 질환 또는 상태를 말한다.

제3조 (절차)

1. 진단명 선정원칙
   1) 외래진료 후 퇴원 시 진단은 최종진단으로 기재하여야 한다.
   2) 최종진단은 주진단과 기타진단으로 구분하여 기재하여야 한다.
   3) 주진단과 기타진단은 책임 있는 의사에 의해 기재되어야 한다.
   4) 주진단은 내원 시 상황, 진단적 검사, 치료 등을 고려하여 최종적으로 밝혀진 진단 중 병원 치료를 필요로 하게 만든 가장 중요한 원인이 되었던 진단으로 선정한다.
   5) 주진단이 여러 개인 경우에는 중요한 순서에 따라 우선순위를 정하고 가장 중요한 주진단을 제일 먼저 입력한다.
   6) 진단명은 질환의 정확한 부위와 원인이 표현되도록 기재한다.
   7) 수술환자의 경우 수술 전·후 진단명이 상이한 경우에는 수술 후 진단명을 최종진단으로 기재해야 한다.
   8) 전과가 이루어지는 경우에 환자의 주진단은 해당과의 주진단이 아니라, 입원기간 전체를

고려하여 가장 중요한 진단을 선정한다.

9) 입원 시 진단(Impression) 또는 임시진단(Temporary diagnosis)은 입원기간 중에 생성된 진단정보가 전혀 없을 때만 주진단으로 사용 가능하다.

10) 7개 DRG(Diagnosis Related Group) 환자를 포함한 모든 입원환자의 주진단, 기타진단에 POA 코드를 부여한다.

(1) Y 코드: 해당 진단이 입원 당시에 존재한 경우

(2) N 코드: 해당 진단이 입원 당시에 존재하지 않은 경우

(3) W 코드: 해당 진단이 입원 당시에 존재하였는지 의료진이 임상적으로 결정할 수 없는 경우

(4) U 코드: 해당 진단이 입원 당시에 존재하였는지 결정할 수 있는 기록이 충분하지 못한 경우

(5) 질환의 후유증, 정상 출산, 선천성기형, 외인코드, 보조코드에 해당하는 코드에 대해서는 POA를 기재하지 아니한다.

2. 진단명 및 진단코드 관리원칙

1) 진단명, 진단코드, 진단마스터는 의무기록팀에서 관리한다.

2) 보건의료정보관리사는 제1항에 따라 주진단과 기타진단이 구분 기재되어 있는지 확인한다.

3) 보건의료정보관리사는 기재된 진단명이 진단명 선정원칙 및 주진단, 기타진단 정의에 부합하는지를 검토 및 관리한다.

4) 퇴원요약의 최종진단은 입원기간의 모든 검사와 치료를 완료한 후 최종적으로 내려진 진단이므로, 퇴원 후 보고된 검사결과에 의해 퇴원 시 진단이 변경될 수 있는 경우 보건의료정보관리사는 작성자 또는 주치의(담당교수)에게 알려 확인 및 수정할 수 있도록 한다. 보건의료정보관리사는 최종 확인된 진단에 대해 진단마스터를 이용하여 퇴원요약정보 데이터베이스에 진단명 및 진단코드를 입력한다.

5) 보건의료정보관리사는 DRG(Diagnosis Related Group)을 포함한 모든 입원환자의 주진단과 기타진단에 입력된 POA가 부여 기준에 부합하는지를 검토 및 관리한다.

6) 보건의료정보관리사는 입력된 POA의 누락 및 오류가 있는 경우 POA 관리 전산시스템을 통해 작성자 또는 주치의(담당교수)에 질의하여 POA가 정확하게 입력되도록 관리한다.

7) 보건의료정보관리사는 의무기록 작성자를 대상으로 진단명 선정 원칙과 POA 입력에 대한 교육을 정기적 또는 필요시 수시로 진행하며, 정확한 POA 관리를 위한 개선 활동을 진행한다.

8) 보험심사관리사는 건강보험요양급여비용 청구 및 적정성평가를 위하여 건강보험 요양급여 기준에 따라 DRG(Diagnosis Related Group)를 포함한 모든 입원/외래 환자의 청구진단을 관리한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2018년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)